

Colecistite aguda · diagnóstico e cirurgia

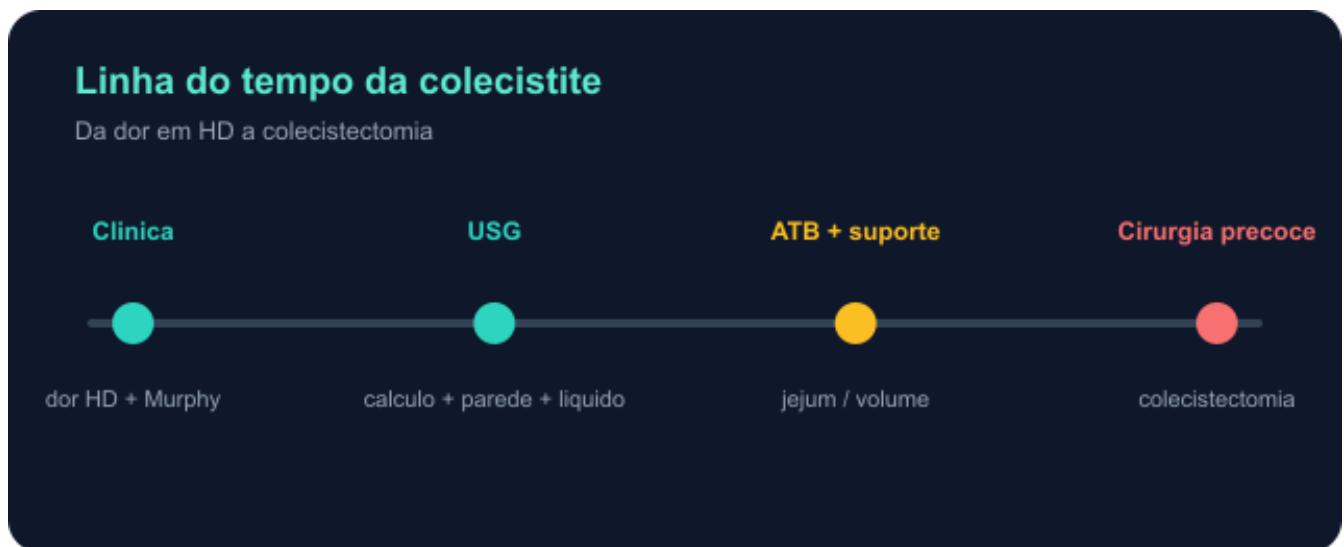
Colecistite aguda litiásica = inflamação da vesícula por obstrução do cístico. Clínica + USG + inflamação sistêmica fecham o diagnóstico; a colecistectomia precoce é o padrão no candidato cirúrgico.

Tokyo — diagnóstico

Lembre - Tokyo — diagnóstico

Sinais locais (Murphy, massa/dor em HD) + sistêmicos (febre, PCR/leucócitos) + imagem (espessamento, líquido pericolecístico, cálculo/impacto). Colangite e coledocolitíase pedem abordagem diferente.

Timeline de prova: suspeita clínica !' USG !' ATB + suporte !' cirurgia precoce (idealmente <72 h).



Conduta

- Jejum, analgesia, volume e antibiótico cobrindo enterobactérias ± anaeróbios
- Colecistectomia laparoscópica precoce na maioria dos casos operáveis
- Alto risco cirúrgico / complicação: drenagem percutânea (colecistostomia) como ponte
- Suspeita de coledocolitíase: lab colestático + imagem; CPRE conforme critério

Diagnóstico diferencial

Condição | Pista

Cólica biliar | Dor autolimitada, sem inflamação sistêmica

Colangite | Charcot/Reynolds — icterícia + infecção via biliar

Hepatite / abscesso | Enzimas / imagem hepática

Úlcera perforada | Peritonite + ar livre

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Colecistite alitiásica (UTI, jejum prolongado, vasculopatia) tem alta morbidade — não exclua só porque o USG 'não mostrou cálculo'. Imagem seriada e limiar baixo para drenagem/cirurgia.